

AFMCP Chap6 운반대사심혈관기능이상 Part4 요약

식이 개입 · 보충제 · 임상 흐름 경로

핵심 개념

- 대사심혈관 환자 치료 원칙: 음식 우선(Food First), 단계적 접근
- ABCD 영양 평가: Anthropometrics / Biomarkers / Clinical exam / Diet review
- 목표: 인슐린 자극 ↓ + 인슐린 감수성 ↑

식이 전략 요약

단계적 식이 진행

- 1단계: 코어 푸드 플랜 + 식물영양소 스펙트럼 (작은 변화부터)
- 2단계: 필요 시 대사심혈관 플랜 추가 (유제품 無, 글루텐 無, 저단순당)
- 3단계: 해독 식단, 미토 식단 등 치료적 식단 활용

지중해 식단과의 공통점

통곡물·채소·콩류·올리브오일·생선 강조 / 적색육·유제품·가공식품 최소화

장 건강 (DIGIN + 5R)

Remove → Rebalance → Repair → Repopulate → Replace

핵심 보충제 정리

- 알파-리포산 (ALA): 세포 수준 인슐린 감수성 개선, 임상 효과 우수
- CoQ10: 인슐린 감수성 + 미토콘드리아 에너지 전반에 유익
- 비타민 D: 수많은 불균형 개선의 핵심
- 비타민 C·E + 항산화제: 식물영양소 스펙트럼에서 획득, 세포 손상 회복
- 마그네슘: 인슐린 저항성, 골격근 포도당 흡수 최적화
- 오메가-3 지방산: 인슐린 저항성, VLDL 상승 시 지질 개선
- 셀레늄·아연·구리: 심부전 환자 효소 보조 인자 보충

약물 vs 기능의학 접근 비교 (간략)

소장: 알파-글루코시다제 억제제 vs 섬유질 + 저혈당 지수 식품

골격근: 비구아나이드/TZDs vs ALA + 오메가-3 + 비타민D + 운동 + 마그네슘

췌장: 설포닐우레아 vs 비타민D + 항산화제

뇌/위: GLP-1 작용제 vs 섬유질 (위 배출 지연)

임상 흐름 경로 체크리스트

- [] 임상 소견 파악 (신체계측 + 심혈관 + 다중 시스템)
- [] 검사실 검사 (TG/HDL, ApoB, 소밀도LDL, HbA1c, 공복인슐린 등)
- [] 개인별 ATM 구성 (식이·유전·생활습관·스트레스·장 건강)
- [] 환자에게 설명 + 개입 우선순위 공동 결정
- [] 필요 시 협진팀 연계 (약사: 심혈관약 감량 시 중요!)
- [] 식이: 코어 + 식물영양소 플랜 시작
- [] 생활습관: 수면·운동·스트레스·관계
- [] 장 건강: DIGIN 평가 + 5R 진행
- [] 보충제 처방 (우선: ALA, CoQ10, 비타민D, 마그네슘, 오메가-3)

핵심 기억 문장

코어 푸드 플랜 + 식물영양소 스펙트럼 = 지중해식과 동일 효과. 1%씩 작은 변화로 시작하되 장 건강 먼저 다루고, 보충제는 ALA·CoQ10·비타민D·마그네슘·오메가-3를 우선 고려하라.